ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.4—2008

针灸技术操作规范　第4部分：三棱针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 4：Three-edged needle

2008-04-23 发布　　2008-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；

——第2部分：头针；

——第3部分：耳针；

——第4部分：三棱针；

——第5部分：拔罐；

——第6部分：穴位注射；

——第7部分：皮肤针；

——第8部分：皮内针；

——第9部分：穴位贴敷；

——第10部分：穴位埋线；

——第11部分：电针；

——第12部分：火针；

——第13部分：芒针；

——第14部分：鍉体；

——第15部分：眼针；

——第16部分：鼻针；

——第17部分：口唇针；

——第18部分：腹针；

——第19部分：腕踝针；

——第20部分：毫针基本刺法；

——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第4部分。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分负责起草单位：天津中医药大学。

本部分参加起草单位：辽宁中医药大学、北京中医药大学。

本部分主要起草人：郭义、陈泽林、李桂兰、裴景春、刘清国。

本部分参加起草人：孟向文、王卫、郭永明、陆彤、王立存、任秀君、卞景芝、王秀云、周志良、图垭、车永哲、丁晶、陈爽白。

针灸技术操作规范　第4部分:三棱针

1　范围

GB/T 21709的本部分规定了三棱针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本部分适用于三棱针技术操作。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 21709的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 21709.5　针灸技术操作规范　第5部分:拔罐

3　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

3.1

三棱针点刺法　three-edged needle pricking

用三棱针快速刺入人体特定浅表部位后快速出针的方法。

3.2

三棱针刺络法　collateral puncturing with a three-edged needle

用三棱针刺破人体特定部位的血络,放出适量血液的方法。

3.3

三棱针散刺法　scattered needling with a three-edged needle

用三棱针在人体特定部位施行多点点刺的方法。

3.4

三棱针挑治法　piercing with a three-edged needle

用三棱针刺入人体特定部位,挑破皮肤或皮下组织的方法。

4　操作步骤与要求

4.1　施术前准备

4.1.1　针具选择

根据病情需要和操作部位选择不同型号的三棱针。针身应光滑、无锈蚀,针尖应锐利、无倒钩。

4.1.2　部位选择

根据病情选取适当的施术部位。

4.1.3　体位选择

选择患者舒适、医者便于操作的施术体位。

4.1.4　环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

4.1.5　消毒

4.1.5.1　针具消毒:应选择高压消毒法。宜选择一次性三棱针。

4.1.5.2　部位消毒：可用75%乙醇或碘伏在施术部位消毒。

4.1.5.3　医者消毒：医者双手应用肥皂水清洗干净，再用75%乙醇擦拭。

4.2　施术方法

4.2.1　三棱针点刺法：点刺前，可在被刺部位或其周围用推、揉、挤、捋等方法，使局部充血。点刺时，用一手固定被刺部位，另一手持针，露出针尖3 mm～5 mm，对准所刺部位快速刺入并迅速出针，进出针时针体应保持在同一轴线上。点刺后可放出适量血液或黏液，也可辅以推挤方法增加出血量或出液量。

4.2.2　三棱针刺络法：刺络前，可在被刺部位或其周围用推、揉、挤、捋等方法，四肢部位可在被刺部位的近心端以止血带结扎，使局部充血。刺络时，用一手固定被刺部位，另一手持针，露出针尖3 mm～5 mm，对准所刺部位快速刺入后出针，放出适量血液，松开止血带。

4.2.3　三棱针散刺法：用一手固定被刺部位，另一手持针在施术部位点刺多点。

4.2.4　三棱针挑治法：用一手固定被刺部位，另一手持针以15°～30°角刺入一定深度后，上挑针尖，挑破皮肤或皮下组织。

注：三棱针施术后，可配合拔罐。拔罐见GB/T 21709.5。

4.3　施术后处理

施术后，宜用无菌干棉球或棉签擦拭或按压。中等量或大量出血时，可用敞口器皿承接，所出血液应作无害化处理。三棱针治疗出血量参见附录A。

5　注意事项

5.1　操作部位应防止感染。

5.2　孕妇及新产后慎用，患者精神紧张、大汗、饥饿时不宜刺。

5.3　注意血压、心率变化，注意晕针或晕血的发生。

5.4　勿伤及大动脉。

5.5　出血较多时，患者宜适当休息后离开。医者避免接触患者所出血液。

6　禁忌

6.1　凝血机制障碍的患者禁用。

6.2　血管瘤部位、不明原因的肿块部位禁刺。

附　录　A
（资料性附录）
三棱针治疗出血量计量

A.1　微量：出血量在 1.0 mL 以下（含 1.0 mL）。

A.2　少量：出血量在 1.1 mL～5.0 mL（含 5.0 mL）。

A.3　中等量：出血量在 5.1 mL～10.0 mL（含 10.0mL）。

A.4　大量：出血量在 10.0 mL 以上。